EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90759
SERVICIO : MEL HOMBRES HSC
FECHA : 2024-08-16 12:26:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: GUSTAVO DEL CARMEN OLGUIN MUNOZ			RUN	: 11.443.774-3
F.Nac	: 05-06-1969	Edad	: 55 AÑOS, 2 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-15	Fecha Egreso	: 2024-08-16 12:26:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I74.9-EMBOLIA Y TROMBOSIS DE ARTEIA NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

CELULITIS DE EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA
DEPRESION
SE DESCARTA TVP

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. L03.1-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIENBROS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

AP Depresión
Alergia niega
CX: Varicectomía EID hace +10 años
OH niega Tab niega

Paciente refiere inicio de sintomatología hace +1 mes aproximadamente, presentando dolor, aumento de volumen y calor local en extremidad inferior izquierda. Inicia tratamiento con Amoxicilina con ac clavulánico por 7 días, además de analgesia y antiinflamatorios.
Evolución favorable con disminución de eritema y aumento de volumen, persistiendo dolor, por lo que reacude a servicio.

Se toman exámenes de laboratorio dentro de lo que reporta:
Gli: 103 | Crea: 0,90 | CK-MB: 18 | CK: 95 | MDRD: 87,61 | % CK-MB: 18,9 | PCR: 134,7 | Uremia: 30 | Na: 139 | K: 3,90 | Cl: 100 | Hb: 13,6 | Hto: 40,6 | Leuc: 13,20 | Plaq: 382 | INR: 1,05 | PT%: 92 | TTPA: 26 | D-Dimero: 2.316,3

Se rescatan imagenes previas:
TC EII + AngioTC 07/07
Examen sin hallazgos de TVP. Cambios sugerentes de celulitis pierna izquierda.
Engrosamiento de cartílago articular de rodilla izquierda.

Ex físico
Piel: cambios y signos propios de la edad
CP: torax asimétrico, normoexpansible, RSRSPS SA RSCSRSRS SSNG

Abd: RHA+, distendido, globoso a expensas de panículo adiposo
Extremidades: aumento de volumen en EII, comprometiendo pierna, asociado a calor local y eritema delimitado. Se evidencian costras de probable lesión previa no descrita. Dermatitis por éstasis bilateral, comprometiendo mayormente EID.
Neurológico: consciente, orientado en tiempo espacio y persona. Sin signos de focalización o irritación meníngea.

PACIENTE HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, MEJOR CONDICION GENERAL
EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA CON MENOS EDEMA, MENOS ERITEMA, SIN DOLOR

PLAN DE MANEJO:

CONTINUAR TTO POR 7 DIAS
LICENCIA MEDICA POR 11 DIAS

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen liviano, hipograso
3. CEFTRIAXONA 2 GR EV X DIA X 7 DIAS
4. cloxacilina cap 500 mg cada 6h x 7 dias
5. Paracetamol 500 MG 2 COMP CADA 8H
6. Quetiapina 200mg vo noche

EXÁMENES Y RESULTADOS

ECO DOPPLER
EXAMEN NEGATIVO PARA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

LUIS MERA SALTOS
MEDICO TRATANTE
21510269-6

JEFE SERVICIO